

LESIONES DEL MIEMBRO SUPERIOR: LESIONES DEL ANTEBRAZO

Roces Fernández A, Alonso Claro G, Marcos Mesa R.

FRACTURAS DIAFISARIAS DE CÚBITO Y RADIO

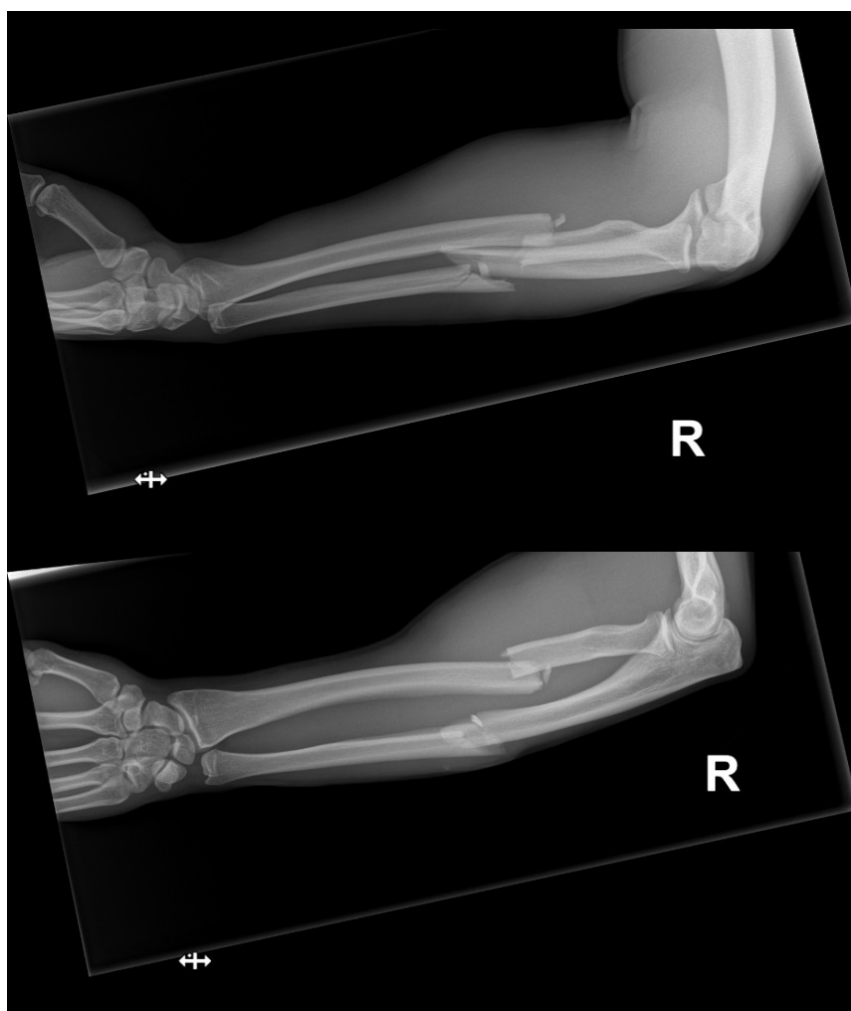
Mecanismo lesional: directo tras un accidente o traumatismo o indirecto tras una caída desde altura con el brazo en hiperextensión. Son más frecuentes en los niños.

Exploración física:** tumefacción y deformidad en antebrazo. Es rara la lesión neurológica. Vigilar que no aparezca un síndrome compartimental.

Pruebas complementarias: Radiografía antebrazo anteroposterior y lateral.

Tratamiento:** la mayoría son desplazadas, por lo que precisan tratamiento quirúrgico.

En caso de que no estén desplazadas se puede optar por un tratamiento conservador mediante un yeso braquiopalmar cerrado o férula si existe mucha tumefacción.



Fractura diafisaria de cúbito y radio.

FRACTURA AISLADA DIAFISARIA DEL CÚBITO

Mecanismo lesional:** por traumatismo directo, “fractura del bastonazo”.

Exploración física:** deformidad y tumefacción en borde cubital del antebrazo.

IMPORTANTE

- Explorar el codo para asegurarse de que es una lesión aislada.

*Pruebas complementarias:*** Radiografía antebrazo anteroposterior y lateral.

*Tratamiento:*** si no está desplazada y presenta una angulación $<10^\circ$ tratamiento conservador mediante yeso braquiopalmar. Si desplazada o angulación $>10^\circ$ tratamiento quirúrgico.

FRACTURA –LUXACIÓN DE MONTEGGIA

Fractura de tercio proximal del cúbito + luxación de la cabeza del radio.

*Exploración física:*** hemartros en codo asociado a la fractura del cúbito. Dolor, deformidad y limitación funcional tanto a la flexo-extensión del codo como a la prono-supinación. Es frecuente la afectación del nervio interóseo posterior (imposibilidad para extender los dedos, pero sí la muñeca).

*Pruebas complementarias:*** Radiografía de antebrazo y codo anteroposterior y lateral.

*Tratamiento:*** quirúrgico.



Fractura- luxación de Monteggia (fractura cúbito proximal + luxación cabeza radial)

FRACTURA-LUXACIÓN DE GALEAZZI

Fractura tercio medio-distal del radio + luxación de la radiocubital distal.

*Exploración física:*** deformidad dolor y limitación funcional en antebrazo y muñeca, se palpa muy bien la cabeza cubital, que se reduce fácilmente.

Pruebas complementarias: Radiografía antebrazo y muñeca anteroposterior y lateral.

Tratamiento: quirúrgico.

BIBLIOGRAFÍA

- Mc Rae. Ortopedia y fracturas de bolsillo. (Temas 19, 20 y 21)
- Campbell. Cirugía ortopédica. Tomo 6. Fracturas y luxaciones. (Capítulo 54)

- Rockwood & green's. Fracturas en el adulto. (Sección II, temas 21 – 30)